

TEMA 5.14 • OFTALMOLOGÍA

cuerpo extraño ocular

PERFIL EUNACOM 6.02.2.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Trauma Ocular: Manejo General y Criterios de Gravedad

Frente a todo trauma ocular, la prioridad primordial del médico general es evaluar el **ABC del paciente** (Descartar TEC severo, fracturas complejas u otras patologías de riesgo vital que priman). Superado esto, el ojo debe estudiarse buscando afanosamente **Signos de Severidad**.

- **Manejo sin signos de alerta (Contusión Simple):** Analgesia (Paracetamol) y control ambulatorio (SOS).
- **Manejo con Signos de Alerta:** Derivación perentoria a la Unidad de Trauma Ocular (UTO) u oftalmólogo experto.

Signos de Severidad (Derivación Inmediata a Especialista)

1. **Hipotonía Ocular:** Signo gravísimo; el globo se "desinfla" y la tensión decae por pérdida de sus fluidos tras un estallido / rotura contenida. 2. **Discoria:** Deformación traumática evidente de la pupila por daño al iris. 3. **Disminución de la agudeza visual:** Siempre es de mal pronóstico. 4. **Hifema:** Presencia de sangre flotante en cámara anterior. 5. **Alteración de los reflejos pupilares.** 6. **Laceración evidente, herida o cuerpo extraño penetrante a simple vista.**

1. Hemorragia Subconjuntival

Espectáculo altamente inquietante para los pacientes ("derrame ocular" o mancha de sangre roja rutilante muy demarcada en lo blanco del ojo) pero habitualmente benigno.

- **Etiología/Causa:**
- - **Espontáneas (Las más frecuentes):** Ruptura capilar secundaria bruscamente a aumentos de presión cefálica transitoria: **Maniobras de Valsalva, vómitos repetidos, pujo extremo, tos intensa, amarrarse zapatos de cabeza, etc.**
- - Asociaciones menos frecuentes: **Hipertensión Arterial** y en raros casos discrasias sanguíneas o coagulopatías subclínicas.
- **Diagnóstico y Aspecto:** Puramente clínico y evidentiísimo.
- **Tratamiento: Observación y educación médica.** Reabsorbe en 1 a 2 semanas solo sin secuelas. NO existe colirio para reabsorber la sangre rápido.
- **Cuándo se Deriva:** Únicamente se evalúa derivar en contexto estricto de **Trauma Fuerte** donde el coágulo subconjuntival es colosalmente grueso que nos oculte físicamente un potencial **estallido del globo por detrás**.

2. Hifema

Es la acumulación hemática de sangre nivelada y en suspensión flotando en la **cámara anterior** del ojo tapando base del iris y pupila.

- **Fisiopatología Traumática:** Casi estricto y unívoco a golpes o traumas profundos directos (Ej: pelota de tenis, pelotazo contundente).
- **Complicaciones Peligrosas Asociadas:**
- 1. **Aumento de Presión Intraocular (Glaucoma agudo):** La sangre maciza obstruye y tapa temporalmente la malla de drenaje trabecular colapsando presiones.
- 2. **Tinción hemofágica de la córnea o el cristalino permanente** que mancha y arruina la visual biológica para siempre.
- **Manejo en Emergencia:** Es considerado de alta severidad y se envía urgente a la UTO para vigilancia, con indicación física primordial:
- - **Reposo Absoluto en POSICIÓN SEMISENTADA (45° a 30°):** Es mandatorio para lograr por simple gravedad que la sangre decante lejos del eje óptico y fuera de la base en pupilas y córnea en contacto íntimo.
- Uso de corticoides tópicos ayuda, pero el monitoreo con **tonometría** constante es la regla hasta el alta.

3. Trauma Ocular Abierto (Penetrante / Estallido)

El trauma ocular abierto comprende un globo perforado ya sea indirectamente por **Estallido Ocular** (trauma romo explosivo) o bien cortado directamente en el **Trauma Penetrante** por objeto cortopunzante externo. Ambas entidades de manejo afín y catastrófico.

EUNACOM CRITERIOS

REGLA DE ORO PROHIBIDA (No Tocar) Ante el mínimo signo inobjetable de Penetración Ocular o de Estallido (Hipotonía o herida transfixiante), el Médico General asume conducta restrictiva: **ABSOLUTAMENTE ESTÁ PROHIBIDO MANIPULAR, LAVAR Y SONDAR EL OJO AFECTADO.** - No aplicar gotas ni anestésicos, ni colorantes como fluoresceína. - No instilar colirios tópicos. - Manda al paciente directamente inmovilizado y sellado por fuera.

- **Manejo prehospitalario permitido (Sistémico):** Vía venosa urgente. Pases masivos de Analgésicos I.V, antieméticos fuertes (previniendo alzas de presión intratorácicas si el paciente vomita), e **Inicio Feroz de Antibióticos profilácticos intravenosos** de cobertura total, previniendo la trágica endoftalmitis cruzada de post trauma masiva (Vancomicina + Cefotazidima / Amplio Espectro).

4. Causticación Ocular (Quemadura Química Quirúrgica)

Trauma químico corrosivo al caer ácidos o **Bases/Álcalis Caústicos** (ej: Soda cáustica, desengrasantes potentes). Provoca altísima morbilidad estromal neosaponificante grave del ojo, que de no actuar puede derretir las adherencias párpado-córnea irremediablemente o necrotizar toda la esclera.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

REGLA DE ORO ACTIVA (Emergencia de Lavado) Constituye **La MÁXIMA URGENCIA PRIORITARIA en medicina y OFTALMOLOGÍA (No Derivable inicialmente).** - No se pospone perdiendo minutos fútiles con anamnesis irrelevantes profundas ni en interconsulta rápida inicial. Se trata atacando y lavando insitu.

- **Manejo Directo y Pasos Ineludibles:**
- 1. **LAVADO CON AGUA o SUERO CIENTÍFICAMENTE ABUNDANTE A CHORRO de presión moderada prolongado:** Efectuar irrigación por un bloque de entre ininterrumpido **20 y 30 minutos al reloj mínimo continuo** buscando remover cualquier residuo sólido remanente base.
- 2. **Técnica del párpado Abierto obligatoria:** El paciente NO debe trancar ni apretar (Cosa biológicamente ardua), forzar apertura o usar retractores y obligarlo al máximo la exposición de todos los fondos del saco conjuntival superior e inferior reventándolos de lavados intensos expuestos.
- 3. Culminados los lavados: **Ungüento Antibiótico Múltiple Empírico.**
- 4. Dejar el ojo **SIEMPRE DESTAPADO SIN PARCHE:** El paciente debe mantener el parpadeo y movilidad para impedir brutal formación indeseada de adherencias cicatrizales biológicas en párpado / córnea fusionada entre sí producto del químico resecaador.
- 5. Recién después derivar urgente a especialista en trauma para evaluar secuelas postquímicas residuales irreversibles.

5. Heridas y Trauma de Párpado Trivial

- Toda herida sangrante periférica del párpado cicatrizará con mucha benignidad a no ser que conste alguno de los **Criterios Quirúrgicos de Gravedad por especialista:**
- Herida **Transfixiante:** Atraviesa de lado a lado la barrera del párpado superior/inferior comprometiendo probablemente además ya el oculto globo interno posterior.

- Heridas y fracturas que separen y corten desastrosamente un trazo de afectación plena del **Borde Libre del Párpado**: Cicatrizan imperfectas, alterando su contacto basal en pestañas afectando o causando triquiasis permanente friccionando.
- Heridas comprometiendo la **vía lagrimal profunda** o canalículos del canto medial, induciendo severa estenosis anatómica si no se canulan antes.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un paciente consulta por sensación de cuerpo extraño en el ojo derecho tras trabajar en carpintería. Al examen se observa ojo rojo. Usted everta el párpado superior y encuentra una astilla de madera en la conjuntiva tarsal. ¿Cuál es la conducta más adecuada después de retirar la astilla?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para cuerpo extraño ocular. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El manejo del cuerpo extraño ocular depende de su ubicación: palpebral, corneal superficial o intraocular penetrante.
- Ante cualquier cuerpo extraño ocular, siempre se debe hacer examen con fluoresceína buscando erosión corneal; si hay erosión se trata con ungüento antibiótico.
- El cuerpo extraño palpebral se retira evertiendo el párpado; técnica: traccionar pestañas suavemente, pedir que mire hacia abajo, presionar con isopo para evertir.
- El cuerpo extraño corneal superficial puede intentar retirarse con irrigación a chorro o isopo con anestesia tópica; el intento con aguja es exclusivo del oftalmólogo.
- El cuerpo extraño intraocular o penetrante se maneja como herida penetrante: no tocar, no retirar, cubrir sin presionar y derivar urgente al oftalmólogo.
- La eversión del párpado superior requiere que el paciente mantenga la mirada hacia abajo durante todo el procedimiento para mantener el párpado evertido.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CUERPO EXTRAÑO OCULAR)

PREGUNTA 1

Un paciente consulta por sensación de cuerpo extraño en el ojo derecho tras trabajar en carpintería. Al examen se observa ojo rojo. Usted everta el párpado superior y encuentra una astilla de madera en la conjuntiva tarsal. ¿Cuál es la conducta más adecuada después de retirar la astilla?

- A) Indicar antibióticos orales y alta sin más exámenes
- B) Realizar examen con fluoresceína buscando erosión corneal y tratar si se confirma
- C) Derivar inmediatamente al oftalmólogo sin intentar ningún tratamiento
- D) Aplicar parche ocular compresivo durante cuarenta y ocho horas
- E) Irrigar el ojo con colirio antibiótico y dar alta

PREGUNTA 2

Un paciente refiere que una partícula metálica se le incrustó en la córnea mientras trabajaba con una amoladora. Al examen se confirma un cuerpo extraño corneal superficial que no ha podido retirarse con irrigación. ¿Cuál es la conducta correcta?

- A) Intentar retirar con una aguja hipodérmica en la consulta
- B) Intentar retirar con un isopo con anestesia tópica tipo propacaína
- C) No tocar el ojo y derivar urgente como si fuera un penetrante
- D) Aplicar ungüento antibiótico y derivar de manera electiva en una semana
- E) Irrigar con suero durante cinco minutos y dar alta si no sale

PREGUNTA 3

Al realizar la eversión del párpado superior para buscar un cuerpo extraño, ¿en qué dirección debe mirar el paciente durante el procedimiento para mantener el párpado evertido correctamente?

- A) Hacia arriba
- B) Hacia un lado
- C) Hacia abajo
- D) Hacia el frente
- E) Puede mirar en cualquier dirección porque la eversión no depende de la posición de la mirada

RESUMEN: CUERPO EXTRAÑO OCULAR

El cuerpo extraño ocular es una consulta muy frecuente en urgencias y el manejo depende fundamentalmente de la ubicación del cuerpo extraño. Hay tres categorías principales: cuerpo extraño palpebral, cuerpo extraño corneal y cuerpo extraño intraocular o penetrante. El cuerpo extraño palpebral se ubica en la cara interna del párpado. Para retirarlo hay que evertir el párpado. Si está en el párpado inferior es más fácil porque simplemente se everta el párpado y se pide al paciente que mire hacia arriba. Si está en el párpado superior hay que usar un isopo o puntero para apoyar y evertir el párpado mientras el paciente mira hacia abajo, técnica que requiere práctica. Después de retirar cualquier cuerpo extraño, siempre hay que hacer un examen con fluoresceína buscando erosión corneal, porque esa es la complicación más frecuente. Si hay erosión, el tratamiento es ungüento antibiótico. El cuerpo extraño corneal superficial puede intentar retirarse con irrigación a chorro con jeringa, o bien con un isopo con anestesia tópica como propacaína. El intento con aguja está reservado para el oftalmólogo porque hay riesgo de perforar el ojo. El cuerpo extraño intraocular o penetrante se maneja exactamente igual que una herida penetrante ocular: no tocar el ojo, no retirar el cuerpo extraño, cubrir sin presionar y derivar urgente al oftalmólogo. La técnica de eversión del párpado superior es clave: traccionar las pestañas con suavidad, pedir al paciente que mire hacia abajo todo el tiempo, y presionar con el isopo para realizar la eversión.